Pacient 9 r.č. 923456/9999 poj.
tel.

Protokol MDT konference

Protokol MDT konference ze dne:

Příjmení a jméno	pacient 9
Rodné číslo	
Pojišťovna	
Bydliště	

☐ předoperačně ☒ pooperačně
☐ úvodní představení ☒ opakované uvedení

Předkládající klinika:

Předkládající lékař:

Diagnóza:
Carcinoma ovarii FIGO IB R0 HGSC BRCA 1,2 negat

Vedlejší diagnózy:
JJ stentu bilat.

Karnovsky-index: 100%

Anamnéza:
hypertenze, DM na dietě

Dosavadní terapie (předcházející operace):
Stp.PDS - hysterectomia cum adnexectomia bilateraliá, omentectomia, apendectomia, stripping peritonei pelvici, lymfadenectomia pelvis et paraaortalis, R0 resekce 2/2026
Stp.chemotherapiam PTX/CBDCA cyclos V anno 3-6/2026

Histologie/Cytologie:
Ovarium vpravo - high grade serózního karcinom

Klasifikace tumoru: *Sy* T 1b N 0 M 0 G R 0 L V

RTG:
RTG S+P: bpn

Onkomarkery:
Ca 125: 7.387 ...67..8..5
2/26 Ca 19-9: 7.869 Ca 72-4: nad 250, Ca 15-3: 249

CT břicha:
CT hrudníku a břicha (nativ + ultravist 370):25.1.2026
V MP josu objemné solidnocystické TI masy expan. charakteru velikosti cca 140x120x90 mm (VD,LL,K) vs jde o TU ovaria. Jinak negativní nález

CT plic:
CT hrudníku a břicha (nativ + ultravist 370):25.1.2026
bez ložiskového nálezu

USG:
SONOGRAFIE (transvag. + transabdom.)
VAG: stav po hysterektomii s oboustrannou adnexetomií, poševní jízva hladká, bez zvýšené vaskularizace, pánev bez volné tekutiny, močový měchýř hladký, uretery bez dilatace, rektum a rektosigmoideum bez postižení, nástěnné i viscerální peritoneum bez patologického nálezu, bez patrné retroperitoneální lymfadenopatie.

ABD: játra homogenní, bez postižení, ledviny bilaterálně bez dilatace KPS, slezina bpn, peritoneum bpn, lymfatické uzliny v retroperitoneu bpn. Ascites ne. Trokarové incize bpn. Laparotomie bpn.
Ré - bez známek recidivy onemocnění, není známek reziduálního tumoru

Otázka pro MDT konference:

pacientk po primární radikální operaci pro HGSC obou ovarií s nulovým pooperačním reziduem s následnými 5 cykly PTX/CBDCA do 2026. 6.cyklus pacientka odmítla

Doporučení MDT konference - navržený postup:

Vzhledem k negativnímu nálezu a rozsahu léčby další terapii neindikujeme.
Dispenzární péče v COP.
Kontrolní odběr Ca 72-4, Ca 19-9, Ca 15-3
Výhledově koloskopie cestou PL.

Plánovaná terapie provedena? ANO

Onkochirurgická operace: ANO

Chirurg:

Onkolog:

Radioterapeut:

Patolog: